PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Risco residual no retorno ao esporte

Números que o atleta, o técnico e a família entendem

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

NA CONSULTA DE LIBERAÇÃO

“Qual a chance de romper de novo?”



a mãe, na consulta de liberação



“Qual a chance de romper de novo?”

✕ “Fica tranquila” — **esconde o risco**

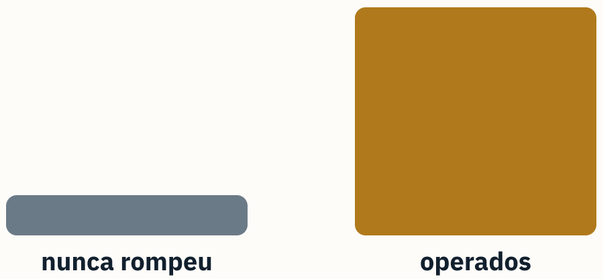
✕ “O risco é bem maior” — **não diz quanto**

✕ “Seis vezes mais” — **assusta e não informa**

O MESMO ESTUDO, DOIS NÚMEROS

Um diz quanto a mais; o outro, quanto

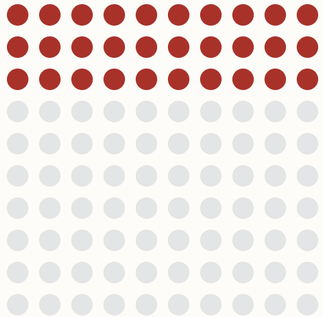
Risco relativo: quanto a mais



quase 6×

taxa por exposição · não diz de onde se parte

Risco absoluto: quanto



~30 em 100

atletas operados com nova lesão do cruzado em dois anos

> Risco relativo não diz de onde se parte. Risco absoluto é o que a mãe perguntou.

Coorte de Cincinnati, 78 atletas jovens · Am J Sports Med 2014

TRÊS FORMAS DE DIZER

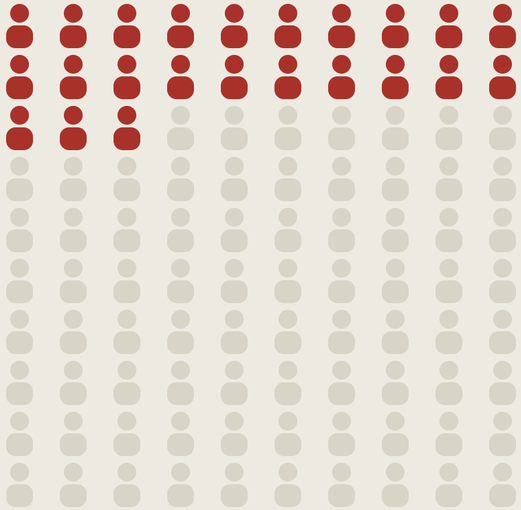
Sempre o grupo de referência e o tempo

		Cem pessoas como quem?	Em quanto tempo?
Risco relativo infla a percepção	**“seis vezes mais”**	✗	✗
Porcentagem de quem? em quanto tempo?	**“trinta por cento”**	✗	✗
Frequência natural responde às duas numa frase	**“de cada cem jovens como você, cerca de trinta em dois anos”**	✓	✓

BMJ 2003

O NÚMERO DESENHADO

Quase um em cada quatro



23 com nova lesão do cruzado

77 sem nova lesão

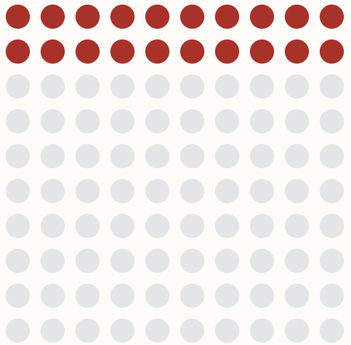
de cada 100 atletas com menos de 25 anos que voltaram ao esporte

> A família vê as duas partes ao mesmo tempo: o risco é real, e a maioria não teve nova lesão.

Metanálise, Am J Sports Med 2016 · 15% no total, 23% nos mais jovens que voltaram

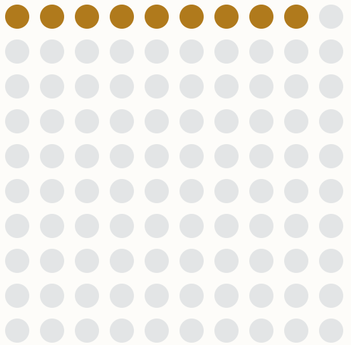
O RISCO QUE NINGUÉM MENCIONA

A maior parte foi no outro joelho



~20 em 100

romperam o cruzado do outro joelho



~9 em 100

romperam o enxerto

> “O enxerto aguenta?” é a pergunta pela metade. A prevenção depois da alta é para os dois joelhos.

Coorte de Cincinnati · Am J Sports Med 2014

E NÃO É SÓ O MESMO LIGAMENTO

Lesão prévia do cruzado e posterior da coxa

lesão prévia do cruzado

2,25

risco relativo · 3 estudos

lesão do posterior da coxa

nem todo número serve para a mesma conversa

✕ **Para a família, não**

relativo, sem conversão para cada cem

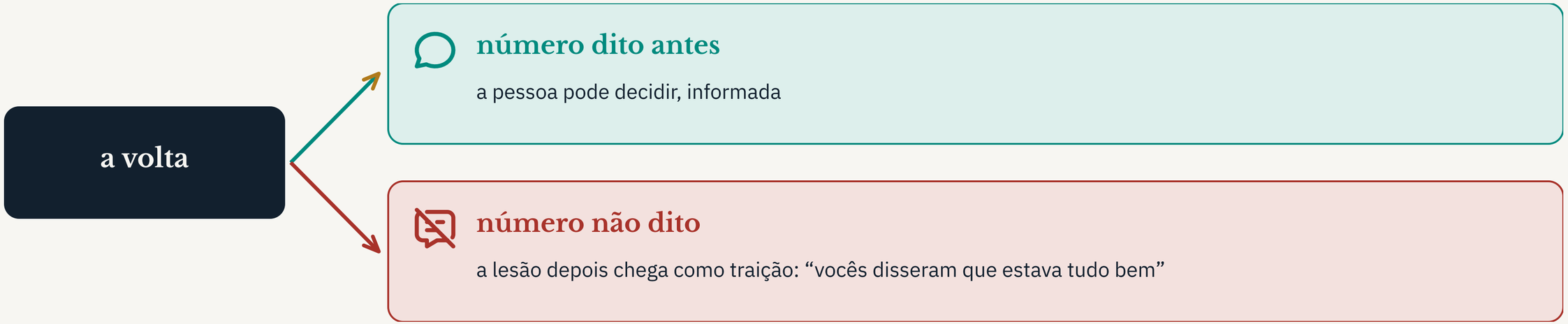
✓ **Para a equipe, sim**

motivo para manter força de posterior e carga depois da alta

Revisão sistemática, Br J Sports Med 2017

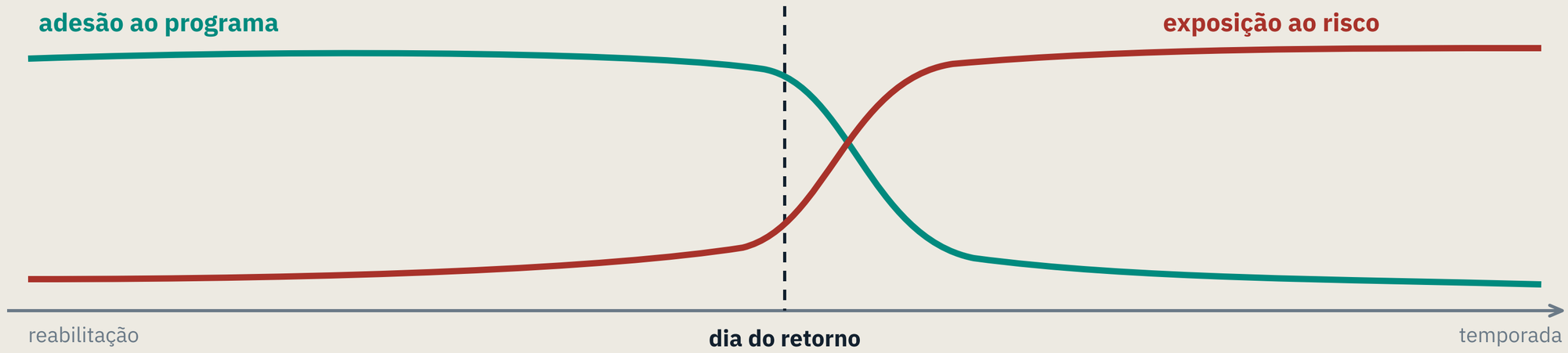
A IDEIA DA AULA

O risco que sobra não é falha do tratamento. É o que o melhor tratamento não tira, e precisa ser dito.



ONDE O NÚMERO COSTUMA SUBIR

As duas curvas se cruzam no pior lugar



Programa dentro do aquecimento, no mínimo que ela vai fazer, reteste marcado antes da alta, e “até o fim da temporada”.

Esquema, sem valores medidos

TRÊS PÚBLICOS

O mesmo risco, três conversas

Atleta

· o número

· o que ela faz para baixá-lo

· os sinais que a fazem parar

Técnico

· tempo de jogo e restrições

· por quanto tempo

· quem avisa se mudar

Família

· o número

· o que foi decidido e por quê

· fazer parte da decisão

Nas três: “explique de volta, com as suas palavras”

se a mãe repete “seis vezes”, a conversa não terminou

Teach-back, revisão sistemática, PLoS One 2020

QUEM PODE SABER O QUÊ

Dado de saúde é dado sensível

O que a lei diz

· dado de saúde é dado pessoal sensível

· tratamento com regras próprias

· criança: consentimento específico de pelo menos um dos pais

Equipe de saúde

prontuário e registro, com o número dito

Técnico e clube

recebem as condições, não o prontuário

Além disso

só com autorização; da família, se menor

> O sigilo profissional já pedia esse cuidado antes da lei.

LGPD, Lei 13.709/2018 · art. 5º, II; art. 11; art. 14, § 1º

A RESPOSTA PARA A MÃE

Quatro frases e uma pergunta de volta

1	**O número**	de cada cem jovens que voltam a um esporte como o basquete, cerca de vinte a trinta têm nova lesão em dois anos, muitas vezes no outro joelho
2	**A outra parte**	setenta a oitenta não têm
3	**O que ela fez**	passou nos critérios: mais perto do menor número, não em zero
4	**Baixa e faz parar**	programa nos dois joelhos; parar se inchar ou falsear

“Pode me dizer, com as suas palavras, o que vai contar em casa?”

a resposta vai para o registro

FECHO DO MÓDULO · TRÊS NÍVEIS

A reabilitação termina num número dito em voz alta

- Decisão: cada profissão no seu campo; a atleta pesa o risco; a gestão garante testes e separa quem avalia de quem tem interesse
- Contribuição: o dia seguinte, o calendário honesto, a dor que ninguém viu
- Reconhecimento: os sinais que qualquer um leva adiante

Médico e fisioterapia

Liberação, riscos inaceitáveis, fases, carga e testes.

Preparação, nutrição e psicologia

Carga no campo, energia para reparar, medo de voltar.

Todos

O joelho que incha, a fase pelo calendário, o “fica tranquila”.

Próximo módulo: preparação física, treinamento e gestão de carga.